MINISTERIO DE JUSTICIA · ARUBA

Un solo servicio de salud y apoyo para todas las instituciones de Justicia

Cómo funciona en la práctica el departamento médico centralizado para KIA, KPA y Guarda Nos Costa

Dr. Ernesto Rodriguez Robelt, MD
Jefe de Unidad de Atención Médica, Deporte y Ejercicio · KIA / DGWA

Presentación al Ministro · octubre de 2026 · Borrador para discusión

LA INDICACIÓN DEL MINISTRO

De un plan de salud para la policía a un servicio para todo el Ministerio

PLAN ESTRATÉGICO, JUNIO DE 2026

- Atención médica para las 4 estaciones de KPA y Guarda Nos Costa
- Una extensión del departamento médico de DGWA en KIA
- 2 médicos y 2 enfermeros adicionales
- En el sitio de 08:00 a 16:00, de guardia 24/7

INDICACIÓN DEL MINISTRO

- Un solo departamento médico, centralizado bajo el Ministerio de Justicia
- Atiende a todas las instituciones de Justicia que lo necesiten
- Justicia Familiar pasa a ser el techo, con un nombre nuevo
- Suma Slachtofferhulp, otros profesionales y una comisión de casos de la comunidad

PARA QUE ELIJA EL MINISTRO

Doce nombres fáciles de decir, centrados en ayudar a la comunidad

Recht op Zorg

NL

“Derecho a cuidado”: recht es justicia y también derecho.

Hart voor Recht

NL

“Corazón por la justicia”: cuidado con rostro humano.

Justitie Dichtbij

NL

“Justicia cercana”: ayuda que llega a la comunidad.

Steunpunt Justitie

NL

“Punto de apoyo de Justicia”: un solo lugar al que acudir.

Huis van Zorg en Recht

NL

“Casa del cuidado y la justicia”: un techo para todo.

De Brug

NL

“El puente”, igual en papiamento: justicia, cuidado y comunidad.

Dienst Zorg & Welzijn Justitie

NL

Estilo formal de servicio del Gobierno (DZWJ).

Hustisia Cuida

PAP

Papiamento: “la justicia cuida”.

Man na Man

PAP

Papiamento: “mano a mano”, justicia y comunidad juntas.

CORA

ES

Centro de Orientación, Rehabilitación y Atención; evoca “corazón”.

JUSTA

EN · ES

Sigla en inglés; en español, “justa”.

Justice Care Aruba

EN

Claro para socios internacionales (JCA).

Mientras no se elija un nombre, esta presentación lo llama “el Servicio Central”.

ESTRUCTURA

Cuatro servicios bajo un mismo techo

Justicia Familiar pasa a ser el techo, con su nombre nuevo

Departamento Médico Central

Médicos, enfermería, psiquiatría, psicología, adicciones y ortopedagogía para todas las instituciones de Justicia

Slachtofferhulp

Apoyo a las víctimas, junto al equipo médico y psicológico

Otros profesionales

Personal de Justicia Familiar y otras disciplinas [por definir]

Comisión de Casos de la Comunidad

Analiza los casos problemáticos de la comunidad y da a cada uno una ruta individual hacia la atención adecuada

ORGANIGRAMA

Departamento Médico Central



A QUIÉN ATENDEMOS

Cuatro puertas a un solo servicio

KIA / DGWA

Prisión

- Puesto médico
- Unidad psiquiátrica forense
- Psicología, adicciones, ortopedagogía

KPA

Policía

- Playa, Santa Cruz, Noord, San Nicolas
- Lands Recherche y Wayaca a pedido

GNC

Guarda Nos Costa

- Ingreso de migrantes
- Tamizaje de enfermedades
- Evaluación previa a la deportación

NUEVO

Otras instituciones de Justicia

- A pedido, cuando el caso lo amerite
- Casos de la comunidad por la comisión

PERSONAS DE CONTACTO

Una persona de contacto y un suplente en cada institución

KIA / DGWA

Contacto + suplente

Puesto médico, unidad forense, acceso y seguridad

KPA

Contacto + suplente

Estaciones, autos, bonos de gasolina, traslados de detenidos

GNC

Contacto + suplente

Ingresos, intérpretes, planificación de deportaciones

OTRAS INSTITUCIONES

Contacto + suplente

Se designan al sumarse al servicio

- Una sola persona a quien llamar cuando un proceso no fluye
- Resuelve problemas de acceso, transporte, equipos, medicamentos y bonos
- Se reúne cada mes con el Jefe del Departamento Médico
- El suplente cubre siempre vacaciones y ausencias

- El Servicio Central también tiene el suyo: el Jefe del Departamento Médico, con un suplente. Nombres y teléfonos van en cada MoU y la administración los mantiene al día.

PERSONAL

De 9 personas hoy a 31, más el equipo de Slachtofferhulp

Puesto	Hoy	Meta	Nuevos	Dónde trabaja
Jefe del Departamento Médico	1	1	–	Central, todos los sitios
Psiquiatra	1*	1	–	Central, todos los sitios
Secretaria	1	1	–	Oficina de KIA
Médicos asistenciales	1	3	2	Rotan: KIA, KPA, GNC
Enfermeros, puesto médico KIA	3	5	2	KIA, fijos
Enfermeros, unidad forense	0	7	7	Unidad forense KIA, turnos de día y de noche
Enfermeros, KPA y GNC	0	3	3	2 circuitos KPA, 1 GNC
Psicólogos, KIA	2	4	2	KIA, fijos
Psicólogos, externos	0	2	2	KPA, GNC, otras instituciones
Terapeuta en adicciones	0	1	1	Central; KIA 3 días por semana
Ortopedagogo	0	1	1	TBS, o unidad forense de KIA
Administración	0	2	2	Oficina central: presupuesto, compras, RR. HH.
Slachtofferhulp, equipo existente	existente	existente	–	Personal del Gobierno que ya existe; sin presupuesto nuevo
Total	**9**	**31**	**22**	*** psiquiatra en nombramiento**

PARA COMENZAR EL PROYECTO

22 plazas nuevas

31 personas pagadas por el Servicio Central, más el equipo existente de Slachtofferhulp

12
enfermeros
7 forense · 3 KPA/GNC · 2 KIA

4
psicólogos
2 KIA · 2 externos

2
médicos
ya identificados en Aruba

1
terapeuta en adicciones
central, KIA 3 días por semana

1
ortopedagogo
TBS o unidad forense

2
administración
presupuesto, compras, RR. HH.

QUIÉN SE QUEDA, QUIÉN SE MUEVE

Equipos fijos, médicos que rotan, dirección central

FIJOS EN KIA

No rotan

- 5 enfermeros, puesto médico
- 7 enfermeros, unidad forense
- 4 psicólogos
- Ortopedagogo, TBS o unidad forense
- Secretaria, oficina de KIA

ROTAN

Todos los sitios

- 3 médicos asistenciales
- Rotan por KIA, KPA, GNC
- Se turnan la guardia semanal

BASE EXTERNA

Fuera de KIA

- 3 enfermeros, KPA y GNC
- 2 psicólogos externos
- Enfermería de KIA los apoya, y al revés

CENTRAL

Se mueven para trabajar y supervisar

- Jefe del departamento
- Psiquiatra
- Terapeuta en adicciones, KIA 3 días por semana

● De guardia cada semana, cada uno con su teléfono: un médico, un enfermero, un psicólogo y la psiquiatra. Sin guardia: el terapeuta en adicciones y el ortopedagogo.

UN DÍA NORMAL DE TRABAJO

Quién está dónde, cada día

Sitio	Horario	Médico	Enfermería	Salud mental
Puesto médico KIA	Lun–vie 08–16, rol de KIA	Médico 1	5 enfermeros, rol de KIA	4 psicólogos; terapeuta en adicciones lun, mié, vie
Unidad forense KIA	24 horas, 7 días: 07–15, 15–23, 23–07	Médico 2; psiquiatra por horario	2 enfermeros de día, 1 de tarde, 1 de noche	Ortopedagogo; psicólogos de KIA
KPA Norte: Playa, Noord	Lun–vie 08–16	Médico 3, circuito externo	1 enfermero	Psicólogo externo a pedido
KPA Sur: Santa Cruz, San Nicolas	Lun–vie 08–16	Médico 3	1 enfermero	Psicólogo externo a pedido
Guarda Nos Costa	Lun–vie 08–16	Médico 3	1 enfermero	Psicólogo externo, tamizaje de ingreso
Fuera de horario	**16–08, fines de semana, feriados**	**Médico de guardia de la semana**	**Enfermero de guardia de la semana**	**Psicólogo de guardia de la semana; psiquiatra por teléfono**

Propuesta: horario de turnos forenses, división Norte/Sur de KPA y días del terapeuta en KIA. La asignación sigue el volumen y la gravedad de los detenidos.

ROTACIÓN

Un ciclo de tres semanas para médicos y guardias

Puesto	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Puesto médico KIA	Dr. A	Dr. B	Dr. C
Unidad forense KIA	Dr. B	Dr. C	Dr. A
Circuito externo + guardia	Dr. C	Dr. A	Dr. B
Enfermero de guardia, KPA/GNC	Enfermero 1	Enfermero 2	Enfermero 3
Psicólogo de guardia	Psicólogo 1	Psicólogo 2	Psicólogo 3
Psiquiatra, por teléfono	Psiquiatra	Psiquiatra	Psiquiatra

- Cada médico está de guardia una semana de cada tres
- 4 teléfonos de guardia: médico, enfermero, psicólogo, psiquiatra
- Cualquier médico cubre cualquier sitio en ausencias

Rol de ejemplo. La rotación de guardia de los psicólogos se define con el equipo. Los puestos en KIA pueden rotar mensualmente por continuidad.

DETENIDOS PSIQUIÁTRICOS

Sin TBS en Aruba: dos opciones para un cuidado adecuado

OPCIÓN A · MEJOR PRÁCTICA

Una institución de cuidado forense

- Similar a las clínicas TBS de Holanda, fuera de la prisión
- Psiquiatras, psicólogos y enfermeros forenses
- Necesita presupuesto, edificio y especialistas propios
- Empezar con un estudio de factibilidad

OPCIÓN B · POSIBLE YA

Reforzar la unidad dentro de KIA

- 7 enfermeros que cubren las 24 horas, de día y de noche
- Día 07–15: 2 enfermeros · tarde 15–23: 1 · noche 23–07: 1
- Todos rotan por turnos de día y de noche: es condición del contrato
- Psicólogos de KIA: terapia, evaluación de riesgo y apoyo en crisis
- Médico diario, psiquiatra por horario, ortopedagogo

- **Las cuentas:** hay 28 turnos por semana (14 de día, 7 de tarde, 7 de noche); 7 enfermeros dan 35, con un 20 % de reserva para vacaciones, enfermedad y formación. Tener 2 enfermeros en cada turno más adelante requeriría unos 3 a 4 enfermeros más.

Supone 5 turnos de 8 horas por enfermero a la semana [confirmar con RR. HH.].

RUTA DE ATENCIÓN

Una sola ruta de atención, en cada sitio, de día y de noche

1

Necesidad

El detenido, el personal o el tamizaje de ingreso detectan una necesidad

2

Enfermería

08–16: evalúa el enfermero del sitio. Fuera de horario: el oficial de turno llama al enfermero de guardia

3

Médico

En el sitio o de guardia: consejo telefónico, visita, receta

4

Resultado

Tratar en el sitio, psicología o psiquiatría, servicio subcontratado, HOH/IMSAN, ambulancia

- Cada paso se registra una sola vez en el expediente médico electrónico y se ve en la siguiente parada de la cadena de custodia.

Criterios de ambulancia, referencias y tiempos de espera según el plan de junio, secciones 4.3–4.7.

COMISIÓN DE CASOS DE LA COMUNIDAD

Cada caso difícil recibe un nombre, un plan y un responsable

Señal
Desde KPA, KIA, GNC, Slachtofferhulp o la comunidad

Evaluación
Ingreso y expediente; los urgentes van primero

Revisión
La comisión se reúne con una frecuencia fija

Plan
Plan individual y un responsable del caso

Seguimiento
Se revisa el avance hasta cerrar el caso

MIEMBROS PROPUESTOS

Jefe del Departamento Médico (preside) · Psiquiatra · Psicólogo · Terapeuta en adicciones · Ortopedagogo · Slachtofferhulp · Profesional de Justicia Familiar · Enlace de la institución que refiere

Frecuencia de reuniones, criterios de admisión y reglas de confidencialidad van en el reglamento de la comisión [por definir].

EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO

Un solo expediente que acompaña a la persona por toda la cadena de justicia

Arresto
Ingreso en la estación de KPA

Detención
KIA o GNC ven el historial

Atención
Recetas, referencias, psicología

Salida
Libertad, traslado o deportación

Por qué importa

- Menor costo: sin historias, exámenes ni traslados repetidos
- Continuidad: la siguiente institución ve lo que hizo la anterior
- Indicadores e informes IVA salen automáticamente

Qué debe ofrecer el sistema

- Hecho para custodia: celda, estatus, traslados, evaluación antes de deportar
- Datos médicos separados de los de custodia, acceso por rol
- 4 idiomas, cifrado, respaldos, ubicación de datos fijada por el Ministerio
- Acceso desde Microsoft Surface con MiFi para el equipo de guardia

La elección de la plataforma es una decisión del Ministerio. Debe tratarse como un elemento central del plan, igual que el personal.

QUIÉN PAGA QUÉ

El Servicio Central paga al personal; las instituciones pagan sus sitios

PRESUPUESTO DEL SERVICIO CENTRAL

- Todos los salarios, con turnos y guardias
- Educación continua de todo el personal
- Material básico: tests psicológicos, estetoscopios, otoscopios, termómetros, oxímetros
- 3 autos: jefe, psiquiatra, psicólogo de guardia
- 4 teléfonos de guardia: médico, enfermero, psicólogo, psiquiatra
- 4 Microsoft Surface con MiFi para el equipo de guardia
- Asignación de teléfono (telefoontoelage) para el resto del personal
- Administración: 2 personas para presupuesto, compras, RR. HH.
- Contratación de proveedores externos
- Expediente electrónico [reparto por confirmar]

CADA INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL SERVICIO

- Oficinas, edificio e insumos de oficina
- Aparatos: ECG, DEA, electrocauterio, camillas, neveras
- Referencias: hospital (HOH), IMSAN, especialistas, dentistas y otros profesionales médicos
- Medicamentos: KIA paga los suyos; KPA y GNC, decisión pendiente
- KPA: 2 autos para médico y enfermero de guardia
- Bonos de gasolina semanales

Un MoU por institución: KIA, KPA, GNC y cada institución que se sume. Presupuesto con precios a los 30 días de la aprobación.

MEDICAMENTOS · DECISIÓN NECESARIA

¿Quién paga los medicamentos de KPA y Guarda Nos Costa?

EL PROBLEMA

- Las farmacias de Botica di Servicio paralizaron las cuentas de KPA y GNC por irregularidades en los pagos
- Guarda Nos Costa no tiene presupuesto para medicamentos
- Sin medicamentos, los detenidos no se pueden tratar en el sitio y terminan en el hospital

OPCIÓN A

Una partida en cada institución

KPA y GNC reciben cada una su presupuesto de medicamentos y pagan a la farmacia a tiempo

OPCIÓN B · PROPUESTA

Un presupuesto en el Servicio Central

Solo medicamentos: el Servicio Central pide y paga, y su administración garantiza el pago a tiempo a la farmacia

OPCIÓN C

Un fondo del Ministerio

Un solo fondo para la medicación de todas las personas detenidas, que administra el Servicio Central

- KIA sigue pagando sus propios medicamentos. Las referencias al hospital, IMSAN, especialistas, dentistas y otros profesionales médicos siguen a cargo de cada institución. En cualquier opción: saldar las cuentas paralizadas, acordar plazos de pago fijos con la farmacia y mantener la revisión anual de la lista de medicamentos.

Decisión del Ministro. Mientras tanto, los medicamentos de los detenidos de KPA y GNC no tienen una fuente de pago segura.

ADMINISTRACIÓN

Dos personas de administración para el Servicio Central

Presupuesto y finanzas

- Prepara y gestiona el presupuesto anual
- Salarios, turnos y guardias
- Informa del gasto al Ministerio

Compras y equipos

- Compra los equipos médicos y tests propios del departamento
- Lleva el inventario y la renovación cada 3 años
- Administra teléfonos, autos y gasolina

Personal

- RR. HH. y nómina de todo el personal
- Roles, semanas de guardia y vacaciones
- Certificaciones y registro de educación continua

Contratos

- MoU con KIA, KPA, GNC y otras instituciones
- Contratos con proveedores subcontratados
- Facturas y recuperación de costos

- Los clínicos dedican su tiempo a los pacientes, no al papeleo: una sola oficina maneja dinero, compras y personal para todos los sitios.

Dos personas: una para presupuesto y finanzas, otra para compras, RR. HH. y contratos [perfiles por confirmar con el Ministerio].

MOVILIDAD

Autos, teléfonos y equipos para cada sitio

Todo el personal

Va al trabajo con su propio transporte

1 auto · KIA

Ya asignado a los enfermeros de guardia de KIA

2 autos · KPA

Médico y enfermero de guardia de la semana

3 autos · Central

Nuevos: jefe, psiquiatra y psicólogo de guardia. Del Departamento Médico Central

- **4 teléfonos de guardia** para el médico, el enfermero, el psicólogo y la psiquiatra de guardia; pasan de mano en cada rotación semanal. El resto del personal usa su propio celular y recibe una asignación de teléfono (telefoontoelage).

- **4 Microsoft Surface con MiFi** (laptop y tablet en uno) para el médico, el enfermero, el psicólogo y la psiquiatra de guardia, para abrir el expediente médico electrónico desde cualquier sitio.

- **Bonos de gasolina cada semana**, entregados por las instituciones que reciben el servicio, para que nunca se detenga por falta de combustible.

Gasolina y mantenimiento de los 3 autos centrales a cargo del Servicio Central [por confirmar].

CALIDAD

Personal formado, un solo punto de contratación

Presupuesto de educación continua

- BLS, ACLS, PHTLS y ATLS para médicos y enfermeros
- Formación en psiquiatría forense para la unidad forense
- Actualización en psicología, adicciones y ortopedagogía
- Certificaciones controladas de forma central; ninguna puede vencer

Servicios subcontratados

- Dentistas, fisioterapeutas, optometristas y otros
- Contratados por el Servicio Central para todas las instituciones
- Una sola lista de precios, un solo estándar de calidad
- A cargo de la institución que recibe el servicio

IMPLEMENTACIÓN

Doce meses, cinco fases

Fase	Cuándo	Qué pasa
0 · Decisión	Mes 1	Decisión ministerial, nombre elegido, techo designado, 2 médicos nombrados, vacantes abiertas, personas de contacto y suplentes designadas
1 · Base	Meses 2–3	MoU con KIA, KPA y GNC; protocolos de KIA adaptados; plataforma de expediente elegida; unidad de administración creada; 5 autos, 4 teléfonos y 4 Microsoft Surface con MiFi asignados; reclutamiento
2 · KIA y KPA	Meses 4–6	KIA reforzado (enfermería, psicología, adicciones); arrancan los circuitos de KPA y la guardia semanal
3 · GNC y forense	Meses 7–9	Enfermero en GNC; unidad forense cubierta 24 horas, de día y de noche, con el ortopedagogo; comisión en marcha
4 · Revisión	Meses 10–12	Primer informe de indicadores; decisión sobre 2 enfermeros por turno y una institución forense

La atención en KPA puede empezar en la Fase 0 con los 2 médicos, 2 autos y 2 teléfonos de guardia, como en el plan de junio.

DECISIONES SOLICITADAS

Siete decisiones para empezar

1. Centralizar el departamento médico bajo el Ministerio, con Justicia Familiar como techo renombrado
2. Elegir el nombre del nuevo departamento
3. Aprobar las 22 plazas nuevas, empezando por los 2 médicos que están listos
4. Dar al Servicio Central su propio presupuesto y unidad de administración, con 3 autos, 4 teléfonos de guardia y 4 Microsoft Surface con MiFi
5. Instruir a KIA, KPA y GNC para firmar MoU: sitios, equipos, autos, bonos de gasolina semanales, persona de contacto y suplente
6. Reforzar ya la unidad forense de KIA y estudiar una institución de cuidado forense
7. Decidir con qué presupuesto se pagan los medicamentos de KPA y Guarda Nos Costa

A los 30 días de la aprobación: presupuesto con precios, borradores de MoU, recomendaciones de nombramiento y plan de trabajo de la Fase 1.